

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075195-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: JANAINA DA SILVA

RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA SOBREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM FACE DE DECISÃO RETRO. CORRETA OBSERVÂNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO. FORNECIMENTO DE “BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (MINIMED™ 780G), SEUS ACESSÓRIOS E INSUMOS DESCARTÁVEIS E DO MEDICAMENTO INSULINA GLARGINA”. PARECER FAVORÁVEL DO NAT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso da parte autora e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5075195-91.2024.4.02.5101

510014837193 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075195-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: JANAINA DA SILVA

RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA SOBREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pedido liminar, na qual MATHEUS DA SILVA SOBREIRA, representado por sua genitora JANAINA DA SILVA objetiva atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso contra a decisão (evento 13), prolatada no âmbito do processo originário de nº 5061520-61.2024.4.02.5101, que deferiu em parte a tutela, por meio da qual a parte autora pleiteia a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que os réus (UNIÃO FEDERAL, ESTADO DO RIO E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO) forneçam a “Bomba de Insulina e Insulina Glargina” para o tratamento de “Diabetes Mellitus tipo 1”, diagnosticado “desde a infância”.

A União interpôs agravo interno no evento processo 5075195-91.2024.4.02.5101/RJ, evento 32, OUT1

É o breve relatório.

VOTO

Passo a analisar o agravo interno juntamente com a decisão, uma vez que os questionamentos interpostos pela União serão objeto da fundamentação do voto.

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 19, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão, verbis: (processo 5061520-61.2024.4.02.5101/RJ, evento 13, DESPADEC1)

"MATHEUS DA SILVA SOBREIRA, pessoa natural qualificada e representada nos autos, propõe ação pelo rito dos Juizados Especiais Federais, com pedido de tutela de urgência, em face da **UNIÃO FEDERAL**, do **ESTADO DO RIO DE JANEIRO** e do **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, objetivando o fornecimento de bomba de insulina e de insulina glargina, para tratamento de diabetes mellitus tipo 1.

Parte autora patrocinada pela DPU.

Petição inicial instruída com documentos (ev. 1, inic1).

Termo de renúncia do montante que exceder 60 salários mínimos (ev. 1, anexo2, fl. 9).

Decisão concedendo a gratuidade de justiça e intimando o NAT para apresentar parecer em 72h (ev. 3).

Decisão renovando a intimação do NAT (ev. 8).

É o breve relatório. Decido.

Por duas vezes, o núcleo técnico deixou transcorrer o prazo sem apresentar o parecer. Em que pese sua importância, trata-se de pleito de urgência, razão pela qual passo a apreciá-lo.

É o relatório. Decido.

Em relação à tutela provisória de urgência, a questão demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do art. 300 do CPC.

Nos termos do art. 196 da CF/88, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

A vinculação da Administração Pública ao fornecimento de assistência integral à saúde, em relação a procedimentos incorporados ao SUS, decorre não apenas de interpretação do art. 196 da CF/88, mas, também, dos preceitos definidos no art. 6º, inciso I, alínea "d", c/c art. 19-M, inciso I, da Lei nº 8.080/90.

Quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp nº 1.657.156/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 106), fixou a seguinte tese:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

Pois bem.

No caso dos autos, conforme relatório médico emitido em 11/03/2024, pelo Dr. Bruno M. de A. Pessoa (CRM 52.0118879-8), do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o autor foi diagnosticado com **diabetes mellitus tipo 1** há 7 anos, apresentando, desde então, episódios de hipoglicemia severas e assintomáticas, que oscilam com hiperglicemias, aumentando o risco de complicações imediatas e sequelas em longo prazo (ev. 1, anexo3, fls. 17/18).

Pontua, ainda, que o quadro tem sido de difícil controle, com grande labilidade glicêmica, razão pela qual recomenda o uso do **sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina)**, visando a diminuir o risco de hipoglicemia.

No tocante à **insulina glargina**, o laudo registra que o paciente já fez uso das insulinas NPH e regular, fornecidas pelo SUS, porém não se mostraram eficazes para o controle desejado.

Muito embora o Núcleo Técnico ainda não tenha se manifestado nestes autos, apesar de duas vezes intimado para tanto (ev. 3 e 8), em consulta ao processo nº 5057811-18.2024.4.02.5101, que tramita nesta Vara Federal, verifica-se que o referido órgão emitiu

parecer recente, em 19/08/2024, sobre a bomba de insulina, também num caso de paciente com diabetes mellitus tipo 1, manifestando-se da seguinte forma (ev. 18/19 daqueles autos):

Diante do exposto, informa-se que o uso de bomba de infusão de insulina - Sistema MiniMed 780G Start Kit e seus insumos: cateter "Set" com 60 cm de tubo de 6 mm de cânula, aplicador Sill-seter "QuickSet", reservatório de 3ml, Guardian sensor 3 + adesivos para fixação, transmissor Guardian Link3, adaptador - Blue e Carelink USB pilhas Energizer AAA, estão indicados ao manejo de quadro clínico da Autora - histórico de hipoglicemias frequentes e graves, (Evento 1, ANEXO2, Página 7).

Salienta-se que o uso da bomba de insulina e seus acessórios apesar de necessário para o tratamento da Autora, não é imprescindível. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois pode ser realizado através de múltiplas doses de insulinas aplicadas por via subcutânea durante o dia (esquema padronizado pelo SUS) ou sistema de infusão contínua de insulina (sistema não padronizado pelo SUS), sendo ambas eficazes no tratamento dos pacientes diabéticos.

Elucida-se, ainda, que de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas de diabetes mellitus tipo 1, o uso de bomba de infusão de insulina (BISI) foi comparado ao esquema basal-bolus com múltiplas doses de insulina em metanálises de ensaios clínicos randomizados, mostrando redução pequena e clinicamente pouco relevante da HbA1c (em torno de 0,3%). Em relação à ocorrência de hipoglicemias, as metanálises mostraram resultados variados: alguns estudos mostram redução da frequência de hipoglicemias graves, enquanto outros não mostram qualquer redução. **Considerando o desfecho qualidade de vida, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) considerou que as evidências ainda são insuficientes para dar suporte à inclusão dessa tecnologia.**

Assim, a CONITEC em sua 63ª reunião ordinária, no dia 31 de janeiro de 2018, recomendou a não incorporação no SUS do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina. **Os membros do Plenário ponderaram que os estudos apresentados não fornecem evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos da terapia** e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido.

No que tange o fornecimento dos insumos no âmbito do SUS, insta mencionar que as seringas com agulha acoplada (em alternativa ao pleito bomba de infusão de insulina), estão padronizadas para distribuição gratuita através do SUS, aos pacientes portadores de diabetes mellitus dependentes de insulina, pelo Programa de Hipertensão e Diabetes - HIPERDIA. Para ter acesso, a Autora deverá comparecer a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, com o receituário atualizado, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação.

Como se constata, a não incorporação do equipamento para tratamento da diabetes mellitus tipo 1 não decorre de inércia da Administração Pública, mas de escolha alocativa com base em discricionariedade técnica em relação aos custos e benefícios para a política pública de saúde.

Nesse cenário, cabe ao Poder Judiciário prestar deferência à discricionariedade técnica administrativa, sob pena de substituir-se ao administrador e, baseando a escolha única e exclusivamente em critérios apurados pelo magistrado, adotar posicionamento diverso do previsto pela Administração, sem o conhecimento necessário para tanto.

No caso concreto, há um estudo prévio, uma recomendação contrária à incorporação e uma portaria que torna pública a decisão de não fornecer a bomba de insulina para o tratamento da diabetes mellitus tipo 1.

Não bastasse, consoante atesta o NAT, a medida almejada não é imprescindível, haja vista não configurar item essencial ao tratamento, que pode ser realizado por meio de múltiplas doses de insulinas aplicadas por via subcutânea durante o dia (esquema padronizado pelo SUS).

Para análise da insulina glargina, reporto-me ao parecer do NAT acostado, na data de 09/07/2024, aos autos de nº 5014106-67.2024.4.02.5101, que tramita na 42ª VF do Rio de Janeiro (ev. 37 daqueles autos):

1. Informa-se que o medicamento pleiteado Insulina Glargina 100U/mL (Lantus® ou Basaglar®) **está indicado em bula** para o manejo do quadro clínico apresentado pelo Autor - diabetes mellitus tipo 1, conforme relato médico.

2. No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado insta mencionar que Insulinas análogas de ação prolongada (grupo da insulina pleiteada Glargina) foram incorporados ao SUS no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento do diabetes mellitus tipo I, perfazendo o grupo de financiamento 1A do referido componente: medicamento com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estado.

* Contudo, **o medicamento Insulina Glargina ainda não integra, uma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.**

3. Cabe ressaltar, que de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêutica (PCDT) do diabetes mellitus tipo 1, publicado pelo Ministério da Saúde é preconizado, dentre outros critérios, o uso da associação insulina de ação rápida + insulina NPH, por pelo menos 03 meses, antes de introduzir a insulina de ação prolongada.

4. No momento, o SUS também disponibiliza, para tratamento do diabetes mellitus tipo 1, no âmbito da Atenção Básica, a insulina NPH em alternativa a insulina de ação longa (grupo da insulina pleiteada Glargina – ainda não disponibilizada).

5. Contudo, cabe observar que nos documentos médicos acostados aos auto processuais (Evento 1 ANEXO2, págs. 10 a 15) foi relatado que o Autor "...com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 na infância, com mau controle e atualmente com complicações secundárias graves como cegueira bilateral, doença renal crônica e crises convulsivas. **Já realizou tratamento com Insulina NPH e Regular por > 1 ano, porém muita variabilidade glicêmica com hipoglicemias graves e risco de coma**". **Portanto, entende-se que a insulina NPH padronizada não configura uma opção terapêutica no presente momento.**

6. O medicamento pleiteado possui **registro na Agência Nacional** de Vigilância Sanitária (ANVISA).

No caso em análise, o médico assistente também salienta que o paciente já fez uso de insulina NPH e regular, sem observar eficácia no controle dos sintomas da diabetes (ev. 1, anexo3, fl. 17), concluindo-se que a alternativa disponibilizada pelo SUS não configura opção terapêutica satisfatória.

Acerca do periculum in mora, o questionário médico respondido pela profissional da rede pública de saúde atesta a possibilidade de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas, bem como o risco de morte (ev. 1, anexo3, fl. 13).

Assim, tenho que o caso se enquadra, ao menos em juízo perfunctório, nas situações excepcionais em que é possível a concessão do medicamento, porquanto demonstrada a necessidade e indicação para o quadro de saúde apresentado, bem como a inviabilidade das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS.

Por essas razões, **DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar que a parte ré forneça ao autor INSULINA GLARGINA, na forma e quantidade indicada pela médica assistente (ev. 1, anexo3, fls 16), devendo a entrega ser condicionada à apresentação de relatório médico atualizado a cada 3 (três) meses, ante a necessidade de reavaliação periódica do quadro. **Prazo: 15 dias.**

Intimem-se para cumprimento, em caráter urgente.

A despeito da solidariedade entre os réus, **direciono o cumprimento do julgado, em primeiro lugar, ao Estado do Rio de Janeiro**, conforme tese fixada pelo STF no RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux (Tema nº 793), haja vista ser responsável por gerir o Componente Especializado em Assistência Farmacêutica do SUS, sobre o qual deve recair, prioritariamente, a obrigação de fornecimento do insumo postulado.

Expeça-se mandado por meio do CADJ, para intimação pessoal do Estado do Rio de Janeiro.

1- Considerando-se que não há, em princípio, necessidade de designação de audiência, **citem-se os réus** para, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 9º da Lei nº 10.259/01), apresentarem contestação, bem como se manifestarem sobre eventual proposta de acordo.

No mesmo prazo, deverão apresentar toda documentação de que disponham para esclarecimento da causa (art. 11 da Lei nº 10.259/01).

2 - Alegando os réus fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou em caso de juntada de novos documentos, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 5 (cinco) dias."

Aduziu que "a referida decisão contraria as provas dos autos, sobretudo os documentos médicos e o parecer da CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS EM SAÚDE juntados em Evento 01, anexo 02, fls. 10 a 27, que atestam que, diversamente do fundamentado pelo d. Juízo na r. Decisão, a medida almejada é imprescindível". Requereu a reforma da decisão para que os réus providenciem à parte autora/recorrente o fornecimento da Bomba de Insulina, conforme prescrição do médico responsável.

É o breve relatório.

Pois bem, sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

No caso, a parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos.

Dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação

O NAT esclareceu que o uso do equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis está indicado ao manejo de quadro clínico do Autor.

III – CONCLUSÃO

1. Trata-se de Autor com diagnóstico de **diabetes mellitus tipo 1** desde a infância, apresentando grande **variabilidade glicêmica**, com **hipoglicemias graves** e **assintomáticas**. Solicita o fornecimento do **equipamento bomba de infusão contínua de insulina** (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis e do medicamento **insulina glargina**.
2. Atualmente, **para a utilização da bomba de insulina**, são consideradas **indicações**: a dificuldade para normalizar a glicemia, apesar de monitoramento intensivo e controle inadequado da glicemia, com grandes oscilações glicêmicas, ocorrência do fenômeno do alvorecer (*dawn phenomenon*), pacientes com **hipoglicemias** noturnas frequentes e **intensas**, indivíduos propensos a cetose, **hipoglicemias** assintomáticas, grandes variações da rotina diária e pacientes com dificuldade para manter esquemas de múltiplas aplicações ao dia¹⁵.
3. Diante do exposto, informa-se que o uso do **equipamento bomba de infusão contínua de insulina** (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis **está indicado** ao manejo de quadro clínico do Autor – **diabetes mellitus tipo 1** desde a infância, com grande **variabilidade glicêmica**, com **hipoglicemias graves** e assintomáticas (Evento 1, ANEXO3, Páginas 10 a 20).
4. Elucida-se que, de acordo com o **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de diabetes mellitus tipo 1**, o uso de bomba de infusão de insulina (BISI) foi comparado ao esquema basal-bolus com múltiplas doses de insulina em metanálises de ensaios clínicos randomizados, mostrando redução pequena e clinicamente pouco relevante da HbA1c (em torno de 0,3%). Em relação à ocorrência de hipoglicemias, as metanálises mostraram resultados variados: alguns estudos mostram redução da frequência de hipoglicemias graves, enquanto outros não mostram qualquer redução. Considerando o desfecho qualidade de vida, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) concluiu que as evidências ainda são insuficientes para dar suporte à inclusão dessa tecnologia¹⁶.
5. Assim, a CONITEC em sua 63ª reunião ordinária, no dia 31 de janeiro de 2018, recomendou a **não incorporação no SUS** do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina. Os membros do Plenário ponderaram que os estudos apresentados não fornecem evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido¹⁷.
6. Salienta-se que o uso da bomba de insulina e seus acessórios **apesar de necessário** para o tratamento do Autor, **não é imprescindível**. Isto decorre do fato, de **não se configurar item essencial** em seu tratamento, pois pode ser realizado através de múltiplas doses de insulinas **aplicadas por via subcutânea** durante o dia (**esquema padronizado pelo SUS**) ou **sistema de infusão contínua de insulina (sistema não padronizado pelo SUS)**, sendo ambas eficazes no tratamento dos pacientes diabéticos¹⁸.
 - Entretanto, consta em documento médico (Evento 1, ANEXO3, Páginas 10 a 20) que o Autor “...com grande **variabilidade glicêmica** em uso de insulina NPH e Regular, trocou pelo análogo de insulina rápida fornecida pelo SUS e análogo de insulina basal **Glargina** e manteve **hipoglicemias graves assintomáticas**”. Portanto, entende-se que o uso do **equipamento bomba de infusão contínua de insulina** (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis, **se configura como melhor opção terapêutica neste momento**.
7. No que tange ao fornecimento do **equipamento bomba de infusão contínua de insulina** (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis no âmbito do SUS, estes **não se encontram padronizados** em nenhuma lista oficial de equipamentos e insumos para dispensação no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro. Assim, **não há atribuição exclusiva do município ou do Estado do Rio de Janeiro quanto ao seu fornecimento**.
8. As **insulinas análogas de ação prolongada** (grupo da insulina pleiteada **glargina**) **foram incorporadas ao SUS** no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento do **diabetes mellitus tipo 1**¹⁹, perfazendo o **grupo de financiamento 1A** do referido componente: *medicamento com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados*^{20,21}.
 - Contudo, as **insulinas análogas de ação prolongada ainda não integram**²², nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.
9. Cabe ressaltar, que de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)²³ do **diabetes mellitus tipo 1**, publicado pelo Ministério da Saúde, é preconizado, dentre

outros critérios, o uso da associação insulina de ação rápida + insulina NPH, por pelo menos 03 meses, antes de introduzir a insulina de ação prolongada. No momento, o SUS disponibiliza, para tratamento do diabetes mellitus tipo 1, no âmbito da Atenção Básica, a insulina NPH em alternativa a insulina de ação longa (grupo da insulina pleiteada glargina – ainda não disponibilizada).

10. Todavia, conforme documento médico (Evento 1, ANEXO3, Página 11) o Autor “...com grande variabilidade glicêmica em uso de insulina NPH e Regular, trocou pelo análogo de insulina rápida fornecida pelo SUS e análogo de insulina basal glargina e manteve hipoglicemias graves assintomáticas, indicando o uso de bomba de insulina”.

11. Neste contexto, cabe ressaltar que a insulina basal glargina pleiteada não se configura como opção terapêutica para manejo do quadro clínico do Autor, neste momento, uma vez que, para a utilização do sistema de infusão contínua de insulina, as insulinas de escolha são as insulinas análogas de ação rápida (lispro, asparte e glulisina)²⁴.

12. Isto posto, informa-se que o Autor já utiliza o “análogo de insulina rápida fornecida pelo SUS”, conforme consta em documento médico (Evento 1, ANEXO3, Página 11).

- Neste sentido, cabe ressaltar que o grupo das insulinas análogas de ação rápida foi incorporado ao SUS para o tratamento do diabetes mellitus tipo 1, conforme os critérios de acesso definidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da referida doença.

- ✓ No momento, o Ministério da Saúde disponibiliza a insulina análoga de ação rápida. A dispensação é feita pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

- ✓ Em consulta realizada ao Sistema Nacional da Assistência Farmacêutica – Hórus, na presente data, verificou-se que o Autor está cadastrado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o recebimento da insulina análoga de ação rápida ofertada pelo SUS, com retirada autorizada para o período de 24/7/24 a 31/12/24.

13. No que concerne ao valor do medicamento pleiteado, para um medicamento ser comercializado no país, é preciso obter o registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a autorização de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)²⁵.

14. De acordo com publicação da CMED²⁶, o **Preço Fábrica (PF)** deve ser utilizado como referência quando a aquisição dos medicamentos não for determinada por ordem judicial e os

medicamentos não se encontrarem relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013, que regulamenta o artigo 4º da Resolução nº 3 de 2011, e o **Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)** é utilizado como referência quando a compra for motivada por ordem judicial, e sempre que a aquisição contemplar medicamentos relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013.

15. Assim, considerando a regulamentação vigente, em consulta à Tabela de Preços CMED, verifica-se que a insulina glargina 100U/mL (Glatus®) solução injetável com 3mL, possui preço de fábrica R\$ 43,81 e preço máximo de venda ao governo R\$ 34,38, para o ICMS 20%²⁶.

16. Elucida-se que o medicamento pleiteado, assim como equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis, possuem registros ativos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

É o parecer.

À 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

Nos termos do parecer: "Entretanto, consta em documento médico (Evento 1, ANEXO3, Páginas 10 a 20) que o Autor "...com grande variabilidade glicêmica em uso de insulina NPH e Regular, trocou pelo análogo de insulina rápida fornecida pelo SUS e análogo de insulina basal Glargina e manteve hipoglicemias graves assintomáticas". Portanto, entende-se que o uso do equipamento bomba de infusão contínua de insulina (Minimed™ 780G), seus acessórios e insumos descartáveis, se configura como melhor opção terapêutica neste momento."

Assim, as alternativas fornecidas pela administração pública já foram utilizadas, não restando outra alternativa para a melhora da saúde da parte autora.

De tal sorte, comprovada a impossibilidade de arcar com os custos da medicação/insumo, a essencialidade, a urgência e a impossibilidade de substituição dos medicamentos/insumos por qualquer outra alternativa terapêutica, resta configurado o dever das rés quanto ao fornecimento do insumo/fármaco/aparelho à parte autora.

No que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

Quanto ao tema, cabe mencionar o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil, que assim dispôs: "ENUNCIADO 40 - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível."

Portanto, afigura-se mais adequado para solucionar o conflito entre o direito à saúde e a capacidade orçamentária do Poder Público, que a transferência hospitalar seja realizada.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

*Por essas razões, defiro parcialmente o requerimento de natureza cautelar de atribuição de **efeito suspensivo ativo** para que os réus forneçam a Bomba de Insulina, conforme prescrição do médico responsável, mediante receituário médico atualizado a cada 3 meses, no prazo de 15 dias a contar dessa decisão. Intimem-se."*

Logo, a decisão liminar, que atribui o efeito suspensivo ativo ao recurso, observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais devendo, dessa maneira, ser ratificada.

Por tais razões, voto por **CONHECER E PROVER PARCIALMENTE** o recurso da parte autora e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar.